

心脏选择性 β_1 阻滞剂对血脂的影响可能小于非选择性制剂。研究证明, 选择性制剂(阿替洛尔或美托洛尔)增加甘油三酯的幅度小于非选择性制剂(心得安或氧烯洛尔), 但四药均明显增加 VLDL($P < 0.05$), 减少 HDL($P < 0.05 \sim 0.01$), 但 LDL 并不改变。看来具有 ISA 的 β -阻滞剂例如心得静, 可能不明显改变总胆固醇、HDL 或甘油三酯, 也许能抵消利尿药引起的 LDL 增加。

据报告, 混合性 α, β -阻滞剂拉贝洛尔降低总胆固醇而不改变 HDL, 也有报告血脂无变化。当 α, β -受体阻滞时, 未见 β -阻滞剂的典型血脂改变, 证明了 α -肾上腺素能的刺激可抑制脂蛋白酶这一概念。因而, 外周 α -阻滞剂如哌唑啉对血脂有益。

血管扩张剂

研究证明, 间接血管扩张剂哌唑啉能减少总胆固醇和甘油三酯, 同时使 HDL 增加。当它并用心得安时, 后者对血脂的影响就不明显。短程和长程哌唑啉治疗, 对血脂产生相同的有利作用。

研究证明, 血管紧张素转化酶抑制剂巯甲丙脯酸, 不改变总胆固醇或甘油三酯, 当并用噻嗪类利尿药时, 又可阻止后者引起总胆固醇明显增加。

肼苯哒嗪和长压定对脂代谢似无直接影响, 但都是交感神经系统的强效激动剂。增加心率和心肌耗氧量, 对伴有冠心病的高血压患者不利。它们还作用于肾素-血管紧张素-醛固酮系统, 引起钠、水潴留及血容量增加。它们常并用 β -阻滞剂或利尿药, 以期减少副作用, 但后两类药对脂代谢有潜在危害。

意义和结论

现有资料证明, 轻度高血压并非皆须药物治疗, 药物选择也非千篇一律, 使血压下降同等程度的不同药物, 其效益可有差别。选择降压疗法时, 尽量不加重或带来危险因素, 才能既收到良好的降压效果, 又能减缓或预防心血管病的发生。

胡 琛译 薛美荣校

[Arch Intern Med 1985, 145(6):1102]

利福平的药物相互作用

Baciewicz AM 等

利福平是人体药物代谢的强效诱导剂, 可引起肝细胞色素 P-450 含量增多。它的酶诱导作用使某些药物的清除率增加。因此, 利福平与其他药物相互作用具有潜在临床意义。

口服抗凝剂

1975 年 O'Reilly 治疗 8 例病人, 使用华法林 7.5~10 mg/d、利福平 600 mg/d, 共 21 d。最后 10 d 发现低凝血酶原血症效应, 血浆华法林水平明显下降, 尿和粪中华法林代谢物含量增加。

Romankiewicz 等和 Self 等分别报告联用利福平(600 mg/d)和华法林时, 产生治疗作用的华法林维持量极大(20 mg/d), 停用利福平后, 这两个报告中所用的华法林用量须分别减少 60% 和 50%。

Boekhout-Mussert 等发现 2 例联用利福平和苯丙香豆醇(Phenprocoumon)者, 口服抗凝剂需要量增加 2 倍。故在服用期间必须监测凝血酶原时间, 特别在开始或停用抗凝治疗时。

口服避孕药

Reimers 等发现, 并用口服避孕药的结核病人, 出血点和突破性出血发生率增加。NockeFinek 等报告, 88 例口服利福平和避孕药的结核妇女中, 5 例怀孕, 62 例发生出血点、月经间期出血或闭经。

Bolt 等证明, 随着肝细胞色素 P-450 含量增加, 雌二醇和乙炔雌二醇的羟化速率增加 4 倍; 以利福平 600 mg/d 治疗 5~10 d 后进行肝活检时即可发现这种增强。

Gelbke 等观察利福平 (600 mg/d) 对 7 名妇女美雌醇 (Mestranol) 代谢率的影响。利福平治疗者, 美雌醇和 2-羟基乙炔雌二醇的尿排泄率同对照组, 但乙炔雌二醇的尿排泄率 (3.5~4.9%) 则低于对照组 (15~23%)。

口服避孕药和利福平联用, 前者可能无效, 应采用其他避孕方法。

糖皮质激素

文献报告联用利福平和糖皮质激素时, 后者作用减弱。阿狄森氏病患者应用利福平-异烟肼-乙胺丁醇或利福平-异烟肼治疗时, 可引起急性肾上腺皮质危象或功能不全。

另有报告, 联用醋酸可的松和利福平 (450~600 mg/d) 治疗的阿狄森氏病患者, 前者需要量增加 (50~100 mg/d)。Edwards 等发现, 4 例肺结核经利福平 600 mg/d 治疗 6 周, 氢化可的松生成速率上升。认为与利福平的肝微粒体酶诱导作用有关。结核性心包炎、肾病综合征或异体肾移植排斥患者, 当联用利福平和糖皮质激素时, 后者剂量必须增加。

McAllister 等联用利福平 (8 mg/kg/d) 和强的松龙 (20 mg/d) 治疗 7 例病人至少一个月, 利福平使强的松龙的组织利用度减少 66%, 血浆清除率增加 45%。

Powell-Jackson 等用皮质类固醇常规治疗一年的 7 例哮喘病人, 在利福平 600 mg/d 治疗 6 周后, 血浆强的松龙消除半衰期和生物利用度分别为 1.59 ± 0.20 h 和 1041 ± 127 mg/ml/h; 但用安慰剂后分别为 2.79 ± 0.35

h 和 1548 ± 171 mg/ml/h。1983 年的 3 个研究认为, 联用利福平和强的松龙, 后者作用明显减弱, 必须增大剂量。

洋地黄毒甙

Peter 等发现, 联用利福平-异烟肼-乙胺丁醇或利福平的患者中, 血清洋地黄毒甙水平分别下降 $53 \pm 14.9\%$ 和 $54 \pm 6.9\%$ 。洋地黄毒甙半衰期由对照值 8.2 ± 1.4 d 缩短为 4.5 ± 1.5 d; 清除率由 1.2 ± 0.1 ml/min 增至 2.2 ± 0.4 ml/min。

Boman 等报告, 利福平 (600 mg/d) 治疗 10 d 后发生急性心力衰竭伴暴发性肺水肿, 血浆洋地黄毒甙低于治疗水平 (10 ng/ml)。当两药联合治疗时, 应监测血清洋地黄毒甙水平, 以防诱发心衰。

奎尼丁

Ahmad 等报告一例口服奎尼丁 (每 6 h 200mg) 有效的室性心律失常伴昏厥和心悸, 因结核病加用利福平 (600 mg/d) 一周后症状复发, 虽经增加奎尼丁剂量, 其血浆奎尼丁水平仍由 4 mg/L 以上降为 0.5 mg/L 以下。改用异烟肼一周后症状消失, 血浆奎尼丁达治疗浓度。

美沙酮

Kreek 等观察 86 例麻醉药成瘾的结核病人, 口服利福平 (600~900 mg/d) 的 30 例中, 21 例 (70%) 发生麻醉药戒断症状。另外 56 例用其他抗结核药则未见发生。作者又发现, 利福平治疗时, 美沙酮血浆水平明显下降 (33~68%), 但半衰期与对照组无差别; 主要代谢物的尿排泄率增加。

降血糖药

Syvälähti 等报告 16 例甲苯磺丁脲治疗 (1 g, 静注) 的结核病人, 9 例口服利福平 450~600 mg/d 者, 甲苯磺丁脲半衰期缩短 43% (由 330 ± 42 缩短为 186 ± 12 min); 口服利福平 180 分钟后, 血清甲苯磺丁脲浓度下降 30% (由 10.3 ± 0.5 降为 7.7 ± 0.6 mg/dl), 360 分钟后下降 41% (由 6.8 ± 0.6 降为

3.5±0.3 mg/dl)。

Held 等用利福平-异烟肼-乙胺丁醇治疗的 6 例病人, 格列嘧啶 (Glycodiazine; Glymidine) 平均半衰期由 230 缩短为 156 min。

巴比妥酸盐

Zilly 等发现, 静脉注射环己巴比妥 (7.32 mg/kg) 的健康人和肝硬变病人, 口服

利福平后两组病人环己巴比妥的平均半衰期皆明显缩短, 代谢清除率分别增加 3 和 2 倍。

结论

与利福平相互作用的多数药物, 当与利福平联合治疗时须加大剂量, 停用利福平时则须减少剂量。

胡 琛节译 薛美荣校

[Arch Inter Med 1984, 144(8):1667]

高血压的首选药物是哪一种

Pearson RM

在治疗无症状的轻度高血压时, 主要应考虑选择一种不增加症状的药物。利尿药和 β 受体阻滞药仍是常用的首选药物, 但它们的临床地位正在受到较新药物的挑战。

利尿药

小剂量噻嗪类 (例如每晨口服苧氟噻嗪 2.5 mg 或环戊噻嗪 0.5 mg) 价格低廉, 对于多数患者使用方便, 很少产生有症状的副反应。已经确定, 年老患者用利尿药比年轻患者较易奏效。应按患者年龄选择药物, 而不是根据高血压机制 (可能涉及肾素类型) 选药。

对于伴发高血压和充血性心力衰竭的患者, 由于利尿药可同时治疗这两种疾病, 因而肯定使用利尿药。在肾功能正常的患者, 利尿药的抗高血压效力与利尿作用无关。对于某些病症, 如前列腺疾病、低钾血症及葡萄糖耐量降低, 利尿药可使它们恶化。

对于多数患者, 较大剂量的噻嗪类在降压方面并不比最小有效量更有效, 但副反应则与剂量相关。常用的氢氯噻嗪 (双氢克尿噻)/阿米洛利 (Amiloride) 复方制剂最近以小剂量上市是适宜的, 这种制剂可用于治疗开始阶段。在所有新近发现的痛风病例中,

约有一半系由利尿药所致。当有痛风既往史时, 应避免使用噻嗪类。痛风患者当有应用利尿药的特殊适应症时, 应使用螺内酯 (安体舒通)。医学研究委员会在轻度高血压的研究中发现, 对利尿药的抑郁反应发生率意外的高。

噻嗪类利尿药可使血清胆固醇和甘油三酯的水平显著升高, 这项发现使某些医生对长期用利尿药治疗高血压产生怀疑。然而, 最初发现噻嗪类可致高脂血症的研究者最近证实, 血脂增高是暂时性的, 在用药一年后, 血脂值恢复至用药前水平。有趣的是吲达胺并不引起血脂升高。对于妊娠期高血压不应采用利尿药。

老年人对药物的不良反应特别敏感, 对所有抗高血压药包括利尿药的体位反应即是如此。对于老年人高血压是否要治疗, 存在很多争论。作者认为, 对于血压升高有引起中风或心脏病的明显危险的老年人, 如果药物并不增加症状, 则可开始或继续治疗。

β 受体阻滞药

β 受体阻滞药是治疗轻度高血压的另一种主要的首选药物。年轻患者对 β 受体阻滞药发生反应的可能性仅较利尿药略见增大。